

QCM 1 : À propos de l'étiopathogénie des fentes labio-palatines, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Les facteurs environnementaux sont la seule cause.
- B. Les anomalies peuvent être isolées ou associées à des syndromes.
- C. L'exposition aux radiations est un facteur de risque environnemental.
- D. Il n'existe aucun facteur génétique connu
- E. La consommation excessive d'alcool pendant la grossesse est un facteur de risque.

QCM 2 : Concernant le traitement chirurgical des fentes labio-palatines, indiquez les propositions exactes :

- A. La réparation de la lèvre se fait à 10 ans.
- B. La greffe osseuse alvéolaire est réalisée vers 7-9 ans.
- C. La correction de la fente palatine intervient avant 1 an.
- D. Les ostéotomies maxillaires/mandibulaires se font à 5 ans.
- E. La "règle du 10" s'applique au début de la correction chirurgicale.

QCM 3 : Quelle est la forme la plus sévère de fente labiale mentionnée dans le texte ?

- A. Fente labiale unilatérale incomplète (« bec de lièvre »)
- B. Fente labiale bilatérale incomplète
- C. Fente labiale bilatérale complète
- D. Fente palatine isolée
- E. Fente labiale médiane simple

QCM 4 : À propos du kyste du canal thyroglosse, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Il résulte de la persistance du canal thyroglosse.
- B. Il est généralement douloureux dès sa formation.
- C. Il est mobile lors de la protrusion de la langue.
- D. Il survient uniquement chez l'adulte.
- E. Il peut parfois s'enflammer et fistuliser.

QCM 5 : Concernant le traitement du kyste du canal thyroglosse, indiquez les propositions exactes :

- A. Il repose sur une exérèse simple du kyste sans retirer d'os.
- B. L'ablation doit inclure une portion de l'os hyoïde.
- C. La chirurgie doit être réalisée pendant une poussée inflammatoire.
- D. La méthode de Sistrunk est la technique de référence.
- E. Une infection doit être traitée avant la chirurgie.

***QCM 6 : Quelle est la complication la plus grave du kyste du canal thyroïdienne s'il n'est pas excisé ?**

- A. Hémorragie sévère
- B. Transformation en carcinome papillaire thyroïdien
- C. Rupture dans la cavité orale
- D. Survenue d'une thyroïdite chronique
- E. Ankylose de la langue

QCM 7 : Concernant les kystes et fistules des arcs branchiaux, lesquelles de ces affirmations sont correctes ?

- A. Ils résultent d'une résorption excessive des arcs branchiaux.
- B. Les anomalies du deuxième arc branchial sont les plus fréquentes.
- C. Le diagnostic repose principalement sur la biopsie systématique.
- D. Les kystes peuvent être mobiles et indolores.
- E. Une fistulisation cutanée est généralement congénitale.

QCM 8 : À propos du traitement des kystes et fistules branchiaux, quelles affirmations sont justes ?

- A. L'excision doit être faite en présence d'une inflammation pour repérer plus facilement le trajet fistuleux.
- B. Le traitement est exclusivement chirurgical.
- C. Une incision transversale en étages est utilisée pour un meilleur résultat esthétique.
- D. La dissection doit éviter d'approcher la fistule pour minimiser les risques.
- E. Toute la fistule, jusqu'au pharynx, doit être retirée.

***QCM 9 : Où se situent généralement les kystes et fistules dérivés du deuxième arc branchial ?**

- A. Au niveau du conduit auditif externe
- B. À proximité du nerf hypoglosse
- C. Sur le bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien
- D. Sous l'os hyoïde
- E. À la base de la langue

QCM 10 : Concernant les hémangiomes infantiles, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Ils apparaissent uniquement à l'âge adulte
- B. Ils prolifèrent rapidement puis régressent spontanément
- C. Ils sont plus fréquents chez les filles
- D. Ils sont systématiquement douloureux
- E. Ils concernent surtout la tête et le cou

QCM 11 : Concernant les malformations vasculaires, quelles propositions sont exactes ?

- A. Elles sont présentes à la naissance
- B. Elles prolifèrent rapidement comme les hémangiomes
- C. Elles peuvent être capillaires, veineuses, lymphatiques ou artérioveineuses
- D. Elles disparaissent souvent spontanément avant 7 ans
- E. Elles sont causées par des erreurs de développement embryonnaire

***QCM 12 : Quelle est actuellement la classification utilisée pour classer les anomalies vasculaires ?**

- A. Classification TNM
- B. Classification WHO
- C. Classification ISSVA
- D. Classification Bethesda
- E. Classification Dubois

QCM 13 : Concernant le Pectus Excavatum :

- A. C'est une déformation de la paroi thoracique antérieure.
- B. Il est plus fréquent chez les filles que chez les garçons.
- C. Il est souvent associé à une scoliose.
- D. La capacité thoracique est augmentée.
- E. L'origine est souvent génétique.

QCM 14 : À propos du traitement du Pectus Excavatum :

- A. La physiothérapie est systématiquement suffisante.
- B. La chirurgie de Nuss est une option de traitement efficace.
- C. Le traitement est toujours nécessaire, même pour les formes asymptomatiques.
- D. La chirurgie est idéalement réalisée à la puberté.
- E. Un corset thoracique est utilisé en première intention.

***QCM 15 : Quel est l'examen paraclinique de choix pour évaluer la sévérité d'un Pectus Excavatum?**

- A. Radiographie thoracique
- B. Scanner thoracique
- C. Échographie cardiaque
- D. Spirométrie
- E. Bilan biologique standard

QCM 16 : À propos de la hernie diaphragmatique congénitale :

- A. Elle empêche la séparation entre la cavité thoracique et abdominale.
- B. Elle est diagnostiquée en général après la naissance uniquement.
- C. Elle est plus fréquente à droite qu'à gauche.
- D. Elle peut s'accompagner d'hypoplasie pulmonaire.
- E. Elle est toujours isolée sans autres malformations associées.

QCM 17 : Concernant la prise en charge de la hernie diaphragmatique congénitale :

- A. L'ECMO peut être utilisée en préopératoire.
- B. L'alimentation orale est autorisée immédiatement après la naissance.
- C. L'intervention chirurgicale est une urgence immédiate juste après l'accouchement.
- D. Une intubation orotrachéale peut être nécessaire.
- E. Une laparotomie médiane sus-ombilicale est une approche possible.

***QCM 18 : Quel facteur est associé à un meilleur pronostic dans la hernie diaphragmatique congénitale ?**

- A. Présence du foie dans la cavité thoracique
- B. LHR élevé
- C. Diagnostic tardif
- D. Hypoplasie pulmonaire sévère
- E. Absence de traitement chirurgical

QCM 19 : À propos de l'atrésie de l'œsophage :

- A. Elle est toujours associée à une fistule trachéo-œsophagienne.
- B. Elle peut entraîner une hypersalivation chez le nouveau-né.
- C. Elle peut être associée au syndrome VACTERL.
- D. Son diagnostic anténatal est systématiquement posé par échographie.
- E. Son incidence est d'environ 1/3000-4000 naissances.

QCM 20 : Concernant le traitement de l'atrésie de l'œsophage :

- A. Il doit être réalisé d'urgence après la naissance.
- B. Le transport du nouveau-né peut attendre la confirmation radiologique définitive.
- C. La chirurgie classique utilise une thoracotomie extrapleurale droite.
- D. Si la distance entre les moignons œsophagiens est importante, une anastomose primaire est toujours réalisée.
- E. L'abord chirurgical peut aussi être thoracoscopique.

***QCM 21 : Quel élément est utilisé pour évaluer le pronostic des patients atteints d'atrésie de l'œsophage ?**

- A. Classification de Waterston
- B. Score d'Apgar
- C. Test de Guthrie
- D. Classification de Silverman
- E. Score de Ballard

QCM 22 : À propos de la sténose hypertrophique du pylore :

- A. Elle survient principalement chez les nourrissons de moins de 1 mois.
- B. Le sexe masculin est plus fréquemment affecté par rapport au sexe féminin.
- C. La cause exacte de la sténose hypertrophique du pylore est bien identifiée. *
- D. Des facteurs environnementaux, comme l'exposition à l'érythromycine, sont incriminés.
- E. Le tableau clinique peut inclure des vomissements bilieux explosifs.

QCM 23 : Concernant le diagnostic de la sténose hypertrophique du pylore :

- A. L'échographie abdominale est la méthode de diagnostic gold standard.
- B. L'examen au baryum est la méthode principale utilisée pour diagnostiquer la sténose.
- C. La palpation de l'olive pylorique est positive dans 70 à 90 % des cas.
- D. Le diagnostic peut être confirmé par la radiographie thoracique.
- E. Les vomissements sont souvent associés à des signes de déshydratation.

***QCM 24 : Quel est le traitement chirurgical de choix pour la sténose**

hypertrophique du pylore ?

- A. Résection pylorique.
- B. Pyloromyotomie extramuqueuse de Fredet.
- C. Gastrectomie partielle.
- D. Bypass gastro-intestinal.
- E. Endoscopie avec dilatation du pylore.

QCM 25 : Concernant l'atrésie du duodénum :

- A. L'atrésie du duodénum est une obstruction partielle du duodénum.
- B. Elle est souvent associée à d'autres malformations, comme le syndrome de Down.
- C. L'atrésie de type I est la moins fréquente, représentant environ 7 % des cas.
- D. L'incidence mondiale de l'atrésie du duodénum est estimée à 1 sur 6 000 à 10 000 naissances.
- E. La forme la plus fréquente d'atrésie du duodénum est l'atrésie de type II.

***QCM 26 : Quel type de malformation est le plus souvent associé à l'atrésie du duodénum ?**

- A. Syndrome de Marfan.
- B. Syndrome de Down.
- C. Spina bifida.
- D. Malformation de Chiari.
- E. Syndrome de Klinefelter.

QCM 27 : Concernant le diagnostic de l'atrésie du duodénum :

- A. Le signe radiologique de la « double bulle » est un indicateur clé.
- B. Un lavement baryté peut être utilisé pour exclure une malrotation intestinale.
- C. L'échographie cardiaque est rarement nécessaire dans ces cas.
- D. Le volume d'aspirat supérieur à 20 ml suggère une obstruction duodénale.
- E. Le diagnostic peut être posé dès la naissance sur la base de symptômes cliniques et radiologiques.

***QCM 28 : Quelle est la cause la plus fréquente d'obstruction intestinale chez les nouveau-nés ?**

- A. Atrésie du duodénum.
- B. Sténose du colostome.
- C. Atrésie et sténose intestinale.
- D. Hernie inguinale.
- E. Mégacôlon congénital.

QCM 29 : Concernant les types d'atrésie intestinale :

- A. L'atrésie de type I est la plus fréquente et ne touche que la muqueuse et la sous-muqueuse.
- B. L'atrésie de type II est causée par un cordon fibreux reliant le segment proximal dilaté et le segment distal rétréci.
- C. L'atrésie de type IIIa implique une boucle intestinale aveugle avec un mésentère en forme de "V".
- D. L'atrésie de type IIIb est souvent appelée "coque de pomme" et présente une configuration hélicoïdale de l'intestin.
- E. L'atrésie de type IV est une combinaison des types I et III.

QCM 30 : Quelles sont les causes possibles de l'atrésie intestinale ?

- A. Une lésion ischémique intra-utérine au niveau du mésentère.
- B. Une infection virale pendant la grossesse.
- C. Une perturbation vasculaire intra-utérine.
- D. Un volvulus ou une strangulation au cours du développement fœtal.
- E. Une mutation génétique.

***QCM 31 : Qu'est-ce qui caractérise la malrotation intestinale ?**

- A. Une perturbation du processus de rotation et de fixation de l'intestin fœtal.
- B. Une infection virale qui affecte la flore intestinale.
- C. Une obstruction du duodénum par un ligament de Ladd.
- D. Une malformation congénitale du côlon.
- E. Une torsion intestinale sans anomalie de la rotation.

QCM 32 : Quels sont les symptômes fréquents du volvulus intestinal ?

- A. Vomissements bilieux dès les premiers jours de vie.
- B. Distension abdominale rapide et progressive.
- C. Selles fécaloïdes et parfois sanguinolentes.
- D. Pleurs déchirants et absence de transit intestinal.
- E. Présence de douleurs thoraciques aiguës.

QCM 33 : Les formes anatomiques de malrotation intestinale comprennent :

- A. Absence de rotation, où l'intestin grêle se situe dans l'hémiabdomen droit.
- B. Rotation complète de 360°, entraînant une torsion de l'intestin.
- C. Rotation incomplète avec le cæcum situé sur la ligne médiane.
- D. Rotation inversée de 90°.
- E. Rotation complète suivie d'un ancrage défectueux du mésentère.

QCM 34 : Quels sont les symptômes caractéristiques du mégacolon congénital chez le nouveau-né

?

- A. Libération retardée du méconium dans les 24-48 premières heures.
- B. Distension abdominale progressive.
- C. Vomissements bilieux, puis fécaloïdes.
- D. Selles fréquentes et normales dès les premiers jours.
- E. Entérocolite agressive, évoluant vers un sepsis grave.

***QCM 35 : Quel examen paraclinique est de choix pour diagnostiquer le mégacolon congénital ?**

- A. IRM abdominale.
- B. Tomodensitométrie (scanner).
- C. Irrigoclysmie.
- D. Échographie abdominale.
- E. Biopsie rectale.

QCM 36 : Quels traitements peuvent être nécessaires en cas de mégacolon congénital ?

- A. Lavements rectaux répétés pour décompresser le côlon.
- B. Colostomie temporaire si les lavements sont inefficaces.
- C. Traitement médical uniquement sans chirurgie.
- D. Résection chirurgicale du segment aganglionique du côlon.
- E. Antibiothérapie préventive pour les infections abdominales.

QCM 37 : Quelles sont les anomalies fréquemment associées aux malformations anorectales ?

- A. Anomalies génitales.
- B. Anomalies rénales.
- C. Anomalies cardiaques.
- D. Malformations pulmonaires.
- E. Cryptorchidie et hypospadias.

***QCM 38 : Quel examen d'imagerie est le plus important pour diagnostiquer les malformations anorectales ?**

- A. Échographie abdominale.
- B. Radiographie thoracique.
- C. Invertogramme.
- D. IRM abdominale.
- E. Scanner avec agent de contraste.

QCM 39 : Quels sont les traitements possibles pour les malformations anorectales ?

- A. Anorectoplastie pour les malformations basses.
- B. Colostomie pour les malformations hautes ou pour les patients en état critique.
- C. Traitement médical sans chirurgie.
- D. Anorectoplastie en période néonatale pour les malformations hautes.
- E. Chirurgie du côlon à un an.

QCM 40 : Quels sont les facteurs favorables au développement de laparoschisis ?

- A. Âge maternel inférieur à 20 ans.
- B. Tabagisme.
- C. Médicaments vasodilatateurs.
- D. Médicaments vasoconstricteurs.
- E. Consommation excessive de café.

***QCM 41 : Quel est le principal traitement chirurgical pour le laparoschisis ?**

- A. Anorectoplastie.
- B. Réintégration des anses intestinales dans la cavité abdominale et fermeture de la paroi abdominale.
- C. Résection de l'intestin hernié.
- D. Colostomie.
- E. Transplantation d'intestin.

QCM 42 : Quels examens peuvent être utilisés pour diagnostiquer le laparoschisis ?

- A. Échographie prénatale à 18-20 semaines.
- B. Radiographie thoracique.
- C. Alpha-foetoprotéine élevée.
- D. Inspection clinique à la naissance.
- E. Invertogramme.

QCM 43 : Quelles sont les caractéristiques de l'omphalocèle ?

- A. Le sac est recouvert d'une membrane avasculaire et translucide.
- B. Le défaut abdominal est généralement situé à gauche de l'abdomen.
- C. Le contenu du sac est souvent constitué des intestins et du foie.
- D. La membrane recouvrant le sac est composée de 2 couches : péritoine et membrane amniotique.
- E. Le cordon ombilical est inséré au niveau du défaut.

***QCM 44 : Quel examen prénatal permet d'établir le diagnostic d'omphalocèle dès la 18ème semaine de gestation ?**

- A. Radiographie thoracique.
- B. Échographie 2D.
- C. Amniocentèse.
- D. IRM.
- E. Échographie cardiaque.

QCM 45 : Quels sont les traitements possibles de l'omphalocèle ?

- A. Excision de la membrane et réintégration progressive des viscères dans la cavité abdominale.
- B. Fermeture immédiate du défaut sans évaluation préalable.
- C. Utilisation de la technique de Fufezan pour la réintégration des viscères.
- D. Traitement conservateur si des malformations graves empêchent une anesthésie générale.
- E. Résection complète des viscères herniés.

QCM 47 : Quelles sont les caractéristiques de la hernie inguinale ?

- A. La hernie inguinale directe est plus courante chez les enfants que la hernie inguinale indirecte.
- B. La hernie inguinale chez les hommes peut devenir visible dès le premier cri, notamment chez les prématurés.
- C. Les hernies fémorales représentent plus de 50 % des hernies inguinales pédiatriques.
- D. La hernie inguinale est plus fréquente chez les hommes, avec un ratio de 10:1.
- E. Les hernies inguinales sont toujours unilatérales chez les nourrissons.

***QCM 48 : Quel est le traitement indiqué pour une hernie inguinale ?**

- A. Médication par anti-inflammatoires.
- B. Traitement chirurgical avec ligature du canal péritonéo-vaginal à la base.
- C. Surveillance uniquement, sans intervention.
- D. Traitement par radiothérapie.
- E. Traitement conservateur avec antibiotiques.

QCM 49 : Quels sont les symptômes de la hernie inguinale étranglée chez les nourrissons ?

- A. Douleurs avec des pleurs et une agitation inhabituels.
- B. Vomissements entraînant une déshydratation.
- C. Présence d'une tumeur de l'aîne avec une consistance ferme et douloureuse.
- D. Réduction spontanée de la hernie pendant le sommeil.
- E. Augmentation de la taille de la hernie lors de la miction.

QCM 50 : Quelles sont les caractéristiques de la hernie ombilicale ?

- A. Elle est formée uniquement de péritoine et de peau.
- B. Elle est fréquente chez la population pédiatrique afro-américaine, avec une incidence d'environ 50%.
- C. Elle se ferme spontanément chez tous les enfants.
- D. Le risque d'incarcération est élevé.
- E. Les symptômes cliniques sont généralement absents.

QCM 51 : Quel est le traitement de la hernie ombilicale ?

- A. La chirurgie est recommandée si la hernie persiste après 4 ans.
- B. Si le défaut est supérieur à 1,5 cm à 2 ans, une fermeture spontanée est probable.
- C. L'incarcération de l'épiploon peut être une indication de chirurgie précoce.
- D. Le traitement consiste toujours en une surveillance sans intervention chirurgicale.
- E. Une ombilicoplastie peut être réalisée lors de la réparation du défaut.

***QCM 52 : A quel âge la hernie ombilicale se ferme généralement spontanément ?**

- A. 1 an
- B. 3 à 4 ans
- C. 5 à 6 ans
- D. 7 à 8 ans
- E. 10 ans

QCM 53 : Quels sont les types de testicules associés à la cryptorchidie ?

- A. Testicule non palpable, caché, situé intra-abdominalement.
- B. Testicule rétractile, situé au niveau de l'orifice externe du canal inguinal.
- C. Testicule flottant, se retrouvant spontanément dans la bourse scrotale.
- D. Testicule palpable mais non mobilisable par traction au niveau du scrotum.
- E. Testicule absent, ce qui correspond à une anorchidie.

QCM 54 : Quels sont les traitements possibles pour la cryptorchidie ?

- A. Le traitement chirurgical est recommandé dès l'âge de 12 à 18 mois.
- B. La laparoscopie exploratoire est souvent utilisée lorsque le testicule n'est pas palpable.
- C. L'approche combinée inguinale et scrotale est utilisée si le testicule est palpable le long du canal inguinal.
- D. Les médicaments hormonaux sont utilisés pour forcer la descente du testicule.
- E. Le traitement consiste uniquement en une surveillance sans intervention chirurgicale.

***QCM 55 : Quel est le pronostic de la cryptorchidie si elle n'est pas traitée correctement ?**

- A. Le pronostic est favorable, sans complications.
- B. La cryptorchidie peut causer des dysplasie testiculaire mais sans impact sur la fertilité.
- C. Elle peut entraîner une infertilité masculine et d'autres complications graves.
- D. Il n'y a pas de risque de complications si elle est laissée sans traitement.
- E. La cryptorchidie devient toujours asymptomatique avec l'âge.

QCM 56 : Quelles sont les causes principales de scrotum aigu ?

- A. Torsion testiculaire.
- B. Torsion de l'hydatide de Morgagni.
- C. Hernie inguinale étranglée.
- D. Traumatismes scrotaux et testiculaires.
- E. Infection urinaire.

QCM 57 : Quels sont les éléments diagnostiques importants pour la torsion testiculaire ?

- A. La douleur violente et continue, souvent nocturne.
- B. L'augmentation de volume et l'œdème du scrotum.
- C. Le testicule ascensionné vers la partie supérieure du scrotum.
- D. La possibilité d'une torsion manuelle avant intervention chirurgicale.
- E. La présence d'une masse palpable dans l'abdomen.

***QCM 58 : Quel est le traitement principal pour une torsion testiculaire non résolue par détorsion manuelle ?**

- A. Traitement conservateur, avec suivi.
- B. Exploration chirurgicale et orchiectomie si le testicule est non viable.
- C. Utilisation de médicaments anti-inflammatoires uniquement.
- D. Antalgiques et observation sans intervention chirurgicale.
- E. Radiothérapie pour préserver la fonction testiculaire.

QCM 59 : Quelles sont les causes possibles de la stase sanguine dans la varicocèle ?

- A. Passage de la veine rénale gauche par la pince aorto-mésentérique.
- B. La présence de valvules unidirectionnelles dans la veine spermatique gauche.
- C. Spasme du segment distal de la veine spermatique dû au reflux sanguin provenant de la glande surrénale.
- D. La grande longueur de la veine spermatique gauche.
- E. L'absence de veines dilatées dans la veine rénale gauche.

QCM 60 : Quels sont les examens paracliniques recommandés pour le diagnostic de la varicocèle ?

- A. Echographie abdominale.
- B. Phlébographie spermatique.
- C. Biopsie testiculaire.
- D. Test de spermatogenèse par échographie Doppler.
- E. Spermogramme.

***QCM 61 : Quel est le traitement chirurgical pour la varicocèle ?**

- A. Ligature des veines spermatiques dilatées.
- B. Sclérothérapie des veines rénales.
- C. Ablation du testicule affecté.
- D. Observation et traitement médical.
- E. Radiothérapie pour réduire les varices.

QCM 62 : Quelles sont les causes possibles de la torsion ovarienne ?

- A. Kyste ovarien ou tumeur annexielle.
- B. Un ovaire normal, sans pathologie préexistante.
- C. Une grossesse extra-utérine.
- D. Un fibrome utérin.
- E. Une infection pelvienne.

QCM 63 : Quels sont les signes cliniques associés à la torsion ovarienne ?

- A. Douleur violente, localisée dans le bas-ventre, irradiant parfois vers l'aîne et les flancs.
- B. Fièvre élevée et frissons.
- C. Tachycardie et position antalgique.
- D. Nausées, vomissements et constipation.
- E. Sensibilité douloureuse dans le bas-ventre avec défense musculaire.

***QCM 64 : Quel est l'examen paraclinique essentiel pour diagnostiquer une torsion ovarienne ?**

- A. Echographie abdominale.
- B. Tomodensitométrie abdomino-pelvienne.
- C. Spermogramme.
- D. Radiographie abdominale.
- E. Test de grossesse.

QCM 65 : Quelles sont les caractéristiques de l'invagination intestinale ?

- A. Il s'agit d'une forme d'occlusion intestinale mécanique.
- B. L'invagination se produit lorsque l'anse intestinale inférieure pénètre dans l'anse sus-jacente.
- C. Elle est plus fréquente chez les nourrissons âgés de 4 à 10 mois.
- D. Les filles sont plus souvent touchées que les garçons.
- E. L'invagination intestinale est rare chez les enfants de moins de 4 mois.

QCM 66 : Quels sont les facteurs étiopathogéniques de l'invagination intestinale primaire ?

- A. Croissance anormale de la région caecocolique par rapport à l'intestin grêle.
- B. Infection virale saisonnière provoquant une entérocolite.
- C. L'absence d'acollisation du caecocolique ascendant au péritoine pariétal postérieur.
- D. La présence d'une tumeur intestinale.
- E. Un corps étranger dans le tube digestif.

***QCM 67 : Quel est le principal examen paraclinique pour diagnostiquer une invagination intestinale ?**

- A. Échographie abdominale.
- B. Radiographie abdominale avec contraste.
- C. Tomodensitométrie.
- D. Endoscopie digestive haute.
- E. IRM abdominale.

QCM 68 : Quels sont les symptômes caractéristiques de l'iléus méconial simple ?

- A. Absence d'émission de méconium dans les 24-48 premières heures.
- B. Vomissements bilieux.
- C. Rétrécissement de l'anus et du rectum.
- D. Diarrhée avec mucus.
- E. Coliques abdominales intenses.

QCM 69 : Quelles sont les complications possibles de l'iléus méconial compliqué ?

- A. Péritonite méconiale.
- B. Perforation intestinale.
- C. Ascite méconiale.
- D. Diarrhée aiguë.
- E. Kystes biliaires.

***QCM 70 : Quel est le traitement de l'iléus méconial non compliqué ?**

- A. Chirurgie immédiate.
- B. Irrigation intestinale avec un produit de contraste hydrosoluble.
- C. Antibiothérapie intraveineuse.
- D. Résection intestinale.
- E. Réhydratation uniquement.

QCM 71 : Quelles sont les causes possibles de l'obstruction de la lumière appendiculaire dans l'appendicite aiguë ?

- A. Coprolithes.
- B. Corps étrangers.
- C. Obstruction des voies urinaires.
- D. Cicatrices et adhérences.
- E. Infection virale.

QCM 72 : Quelles sont les caractéristiques cliniques de l'appendicite aiguë ?

- A. Douleur initialement localisée au niveau périombilical.
- B. Douleur migrante vers la fosse iliaque droite.
- C. Diarrhée et perte d'appétit.
- D. Vomissements après la douleur.
- E. Selles sanglantes.

***QCM 73 : Quel est le principal traitement chirurgical de l'appendicite aiguë ?**

- A. Appendicectomie.
- B. Antibiotiques parentéraux.
- C. Résection du côlon.
- D. Drainage du péritoine.
- E. Laparotomie pour réparation intestinale.

QCM 74 : Quelles sont les causes possibles de symptômes chez une personne ayant un diverticule de Meckel ?

- A. Hémorragie due à un ulcère muqueux.
- B. Perforation du diverticule.
- C. Infection virale.
- D. Occlusion intestinale par invagination ou volvulus.
- E. Douleur abdominale chronique sans autre symptôme.

QCM 75 : Quelles complications peuvent résulter du diverticule de Meckel chez l'enfant ?

- A. Hémorragie digestive basse.
- B. Péritonite secondaire due à perforation.
- C. Constipation sévère.
- D. Diverticulite de Meckel.
- E. Perforation gastrique.

***QCM 76 : Quel est le principal traitement pour le diverticule de Meckel ?**

- A. Traitement antibiotique à large spectre.
- B. Résection chirurgicale du diverticule.
- C. Radiothérapie pour réduire la taille du diverticule.
- D. Résection du côlon.
- E. Traitement médical de la douleur.

QCM 77 : Quelles sont les caractéristiques cliniques communes chez les enfants atteints de néphroblastome ?

- A. Masse tumorale abdominale asymptomatique.
- B. Hématurie dans 20 % des cas.
- C. Hyperplasie bénigne des reins.
- D. Douleurs abdominales dues à une rupture intratumorale.
- E. Hypertension due à l'activation du système rénine-angiotensine.

***QCM 78 : Quel est le principal traitement pour le néphroblastome ?**

- A. Chirurgie seule.
- B. Chimio- et radiothérapie.
- C. Traitement médical sans chirurgie.
- D. Traitement combiné incluant la chirurgie, la chimiothérapie et parfois la radiothérapie.
- E. Résection par laparoscopie uniquement.

QCM 79 : Quels sont les risques de complications postopératoires après un traitement pour néphroblastome ?

- A. Infection.
- B. Saignements.
- C. Invagination iléo-iléale dans 10 % des cas.
- D. Insuffisance rénale aiguë chez tous les patients.
- E. Tumeur maligne secondaire à un taux de 1,6 %.

QCM 80 : Quels symptômes peuvent être associés au neuroblastome chez les enfants ?

- A. Douleurs osseuses.
- B. Constipation ou rétention urinaire.
- C. Diarrhée aqueuse abondante.
- D. Pertes de cheveux massives.
- E. Bouffées vasomotrices et transpiration excessive.

QCM 81 : Quels examens sont utilisés pour le diagnostic du neuroblastome ?

- A. Radiographie thoracique.
- B. Échographie.
- C. TDM (Tomodensitométrie).
- D. Test de dépistage du diabète.
- E. IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).

***QCM 82 : Quelle est la survie des patients atteints de neuroblastome à faible risque ?**

- A. Inférieure à 30 %.
- B. Supérieure à 50 %.
- C. Supérieure à 98 %.
- D. Entre 60 % et 80 %.
- E. Entre 90 % et 95 %.

QCM 83 : Quelles sont les caractéristiques des tératomes ?

- A. Ils peuvent contenir des tissus de nature différente.
- B. Ils sont toujours bénins.
- C. Ils peuvent être solides ou kystiques.
- D. Ils se développent généralement sur la ligne médiane du corps.
- E. Leur étiopathogénie est liée à des cellules germinales primordiales totipotentes.

QCM 84 : Quels sont les traitements associés aux tératomes ?

- A. La résection chirurgicale des tératomes bénins est généralement curative.
- B. La chimiothérapie est toujours utilisée après une résection chirurgicale.
- C. La chirurgie est accompagnée d'une radiothérapie dans tous les cas.
- D. L'excision des tératomes immatures nécessite une chimiothérapie adjuvante.
- E. L'ovariectomie est le traitement standard des tératomes ovariens bénins.

***QCM 85 : Quel est le pronostic des tératomes, en particulier ceux qui sont bénins ?**

- A. Leur pronostic est généralement favorable, avec plus de 90 % de survie à 5 ans.
- B. Leur pronostic est mauvais, avec moins de 50 % de survie à 5 ans.
- C. Ils entraînent des récidives fréquentes même après une chirurgie complète.
- D. Leur pronostic est modéré, avec 60 % de survie à 5 ans.
- E. Ils ne nécessitent jamais de suivi postopératoire.

QCM 86 : Quels sont les sous-types histologiques des rhabdomyosarcomes ?

- A. Embryonnaire
- B. Alvéolaire
- C. Pléomorphe
- D. Carcinomateux
- E. Sarcomateux

QCM 87 : Quels symptômes sont associés aux rhabdomyosarcomes ?

- A. Masse tumorale évidente dans la région touchée.
- B. Douleur abdominale intense dans la région pelvienne.
- C. Symptômes urinaires comme l'hématurie, fréquence et rétention urinaire dans les tumeurs de la vessie et de la prostate.
- D. Saignements et écoulements dans les tumeurs vaginales.
- E. Tumeurs botryoïdes visibles dans le scrotum.

***QCM 88 : Quel est le taux de survie à 5 ans des tumeurs à faible risque dans le rhabdomyosarcome ?**

- A. Moins de 50 %
- B. 55 à 70 %
- C. Plus de 90 %
- D. 60 %
- E. Moins de 60 %

QCM 89 : Quels sont les facteurs de risque associés à l'hépatoblastome chez l'enfant ?

- A. Syndrome de Beckwith-Weidemann
- B. Polypose adénomateuse familiale
- C. Nourrissons prématurés
- D. Maladies hépatiques chroniques
- E. Cancer du poumon

***QCM 90 : Quelle est la principale caractéristique du carcinome hépatocellulaire chez l'enfant ?**

- A. Il est principalement diagnostiqué avant l'âge de 3 ans.
- B. Il est fréquent chez les nourrissons prématurés.
- C. Il se manifeste souvent par une rupture intrapéritonéale dans environ 10 % des cas.
- D. Il a une très bonne réponse à la chimiothérapie seule.
- E. Il est plus fréquent dans les foies non cirrhotiques.

QCM 91 : Parmi les tumeurs qui peuvent métastaser au foie, lesquelles sont mentionnées dans le texte ?

- A. Neuroblastome
- B. Tumeur de Wilms
- C. Carcinome hépatocellulaire
- D. Ostéosarcome
- E. Lymphome

QCM 92 : Quels sont les facteurs qui influencent l'évaluation et la prise en charge des traumatismes pédiatriques ?

- A. Les différences anatomiques entre les enfants et les adultes
- B. La réponse physiologique des enfants face à un traumatisme majeur
- C. Le niveau de stress des parents
- D. Le statut socio-économique de l'enfant
- E. La formation des professionnels de santé

QCM 93 : Quelles sont les étapes de l'évaluation primaire d'un enfant polytraumatisé selon la séquence « ABCDE » ?

- A. A : Voies aériennes (Airway)
- B. C : Circulation
- C. D : Digestion
- D. E : Exposition (Exposure)
- E. B : Bilans biologiques

***QCM 94 : Quel est le principal signe clinique d'une obstruction partielle des voies aériennes supérieures chez l'enfant ?**

- A. Cyanose généralisée
- B. Stridor inspiratoire
- C. Respiration bruyante
- D. Fréquence cardiaque élevée
- E. Halètement

QCM 95 : Quelles sont les particularités anatomiques de la cage thoracique chez l'enfant qui la rendent plus vulnérable aux blessures thoraciques ?

- A. Une cage thoracique rigide et peu élastique.
- B. Un médiastin plus large que chez l'adulte.
- C. Une faible masse musculaire protectrice.
- D. Un diamètre transversal des voies aériennes plus grand.
- E. Une trachée plus longue que chez l'adulte.

QCM 96 : Quelles sont les méthodes de traitement des lésions thoraciques suivantes ?

- A. Pour un volet costal, la fixation de la fracture est toujours nécessaire.
- B. L'asphyxie traumatique peut être traitée par ventilation en pression positive et tonicité cardiaque.
- C. L'hémothorax nécessite une ponction pleurale dans tous les cas.
- D. Le pneumothorax nécessite souvent un drainage rapide s'il est de type pneumothorax valvulaire.
- E. La contusion pulmonaire se traite uniquement par chirurgie.

***QCM 97 : Quelle est la principale caractéristique du traitement d'un hémothorax ?**

- A. Une ponction pleurale est toujours effectuée dans les premières 24 heures.
- B. Le traitement repose exclusivement sur des antibiotiques.
- C. Il faut généralement une intervention chirurgicale en cas d'hémorragie massive.
- D. Une radiographie thoracique est inutile pour poser le diagnostic.
- E. Les hémothorax modérés ne nécessitent aucun traitement.

QCM 98 : Quelles sont les causes les plus fréquentes des traumatismes abdominaux chez les enfants ?

- A. Chutes de vélo
- B. Guidons de vélo
- C. Accident de voiture
- D. Traumatismes par arme blanche
- E. Traumatismes par arme à feu

QCM 99 : Quels sont les signes cliniques dominants du syndrome d'hémorragie interne ?

- A. Peau pâle
- B. Agitation psychomotrice
- C. Soif intense
- D. Hypotension
- E. Défense musculaire

***QCM 100 : Quelles méthodes sont couramment utilisées pour diagnostiquer un traumatisme hépatique ?**

- A. Échographie abdominale (FAST)
- B. Radiographie abdominale simple
- C. Tomodensitométrie (TDM)
- D. Examen rectal
- E. Scanner thoracique

QCM 101 : Quels sont les principaux mécanismes responsables des traumatismes rénaux ?

- A. Contusions dues à des accidents de la route
- B. Plaies pénétrantes fréquentes chez les enfants
- C. Lésions iatrogènes durant des interventions médicales
- D. Fractures de côtes
- E. Chutes de hauteur

QCM 102. Parmi les options suivantes, lesquelles correspondent au traitement d'un traumatisme rénal de grade I, II ou III ?

- A. Traitement non opératoire
- B. Surveillance dynamique de la pression artérielle et de l'hématocrite
- C. Chirurgie d'urgence pour toutes les lésions
- D. Rééquilibrage hydro-électrolytique
- E. Antibiothérapie

***QCM 103. Quelle est la complication fréquente après un traumatisme rénal ?**

- A. Hypertension rénovasculaire secondaire
- B. Formation d'un uro-hématome
- C. Péritonite
- D. Obstruction des voies urinaires
- E. Formation d'un calcul rénal

QCM 104: Quelles sont les causes principales des brûlures ?

- A. Contact avec des liquides ou des vapeurs chauds
- B. Exposition aux radiations
- C. Contact avec des surfaces froides
- D. Contact avec des produits chimiques
- E. Fractures osseuses

QCM 105: Quelles sont les zones de lésion principales dans une brûlure selon Jackson ?

- A. Zone de coagulation centrale
- B. Zone d'hyperthermie
- C. Zone de stase
- D. Zone d'hyperémie
- E. Zone de cicatrisation

***QCM 106: Quelle est la première étape du traitement des brûlures ?**

- A. Réaliser une greffe de peau
- B. Retirer le patient du danger et refroidir la zone brûlée avec de l'eau
- C. Prescrire des antibiotiques immédiatement
- D. Pratiquer une intervention chirurgicale
- E. Administrer des analgésiques puissants

QCM 107: Quelles sont les fractures courantes observées chez les nouveau-nés suite à l'accouchement ?

- A. Fracture de la clavicule
- B. Fracture du fémur
- C. Fracture du tibia
- D. Fracture de l'humérus
- E. Fracture du radius

QCM 108: Quelles sont les fractures spécifiques observées chez l'enfant ?

- A. La fracture de Greenwood
- B. La fracture du péroné
- C. La fracture sous-périostale
- D. La déformation plastique
- E. La fracture par compression

***QCM 109: Quel type de fracture de la classification de Salter-Harris concerne l'écrasement du cartilage de croissance ?**

- A. Type I
- B. Type II
- C. Type III
- D. Type IV
- E. Type V

QCM 110: Quels sont les facteurs de risque associés à la fracture supracondylienne ?

- A. Pratique des sports de contact
- B. Chutes de hauteur
- C. Hypertension
- D. Ostéoporose
- E. Activités nécessitant une position prolongée debout

QCM 111: Quels traitements sont indiqués pour les fractures supracondyliennes de type I et II ?

- A. Immobilisation dans un plâtre pendant 3 à 4 semaines
- B. Réduction orthopédique et brochage percutané avec broches de Kirschner
- C. Fixation externe
- D. Chirurgie avec ostéosynthèse par vis
- E. Traitement conservateur sans immobilisation

***QCM 112: Quelle est la complication potentielle de la fracture supracondylienne ?**

- A. Douleur au genou
- B. Lésion du nerf cubital
- C. Problèmes respiratoires
- D. Saignement nasal
- E. Fracture du pied

QCM 113: Quels sont les facteurs de risque associés à la dysplasie coxo-fémorale congénitale ?

- A. Première naissance
- B. Sexe masculin
- C. Position pelvienne lors de la naissance
- D. Poids à la naissance supérieur à 4000 grammes
- E. Alimentation maternelle

QCM 114: Quel(s) examen(s) sont couramment utilisé(s) pour diagnostiquer la dysplasie coxo fémorale congénitale chez le nourrisson ?

- A. Radiographie du bassin
- B. IRM
- C. Échographie de la hanche
- D. Scanner abdominal
- E. Test de Barlow

***QCM 115: Quel est le traitement initial pour un nourrisson présentant une dysplasie coxo-fémorale congénitale ?**

- A. Harnais de Pavlik pendant 6 semaines
- B. Chirurgie immédiate
- C. Immobilisation dans un plâtre
- D. Physiothérapie
- E. Prothèse de hanche

QCM 116: Quelles sont les théories qui expliquent l'étiopathogénie de la maladie de Legg-Calvé Perthes ?

- A. Théorie vasculaire
- B. Théorie inflammatoire
- C. Théorie génétique
- D. Théorie traumatique
- E. Théorie nutritionnelle

QCM 117: Quels sont les stades de l'évolution de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?

- A. Stade initial
- B. Stade de croissance
- C. Stade de fragmentation
- D. Stade de réparation
- E. Stade de guérison

***QCM 118: Quel est le traitement recommandé pour un enfant de moins de 8 ans souffrant de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?**

- A. Orthèses de décharge et thérapie physique
- B. Chirurgie immédiate
- C. Arthroscopie de la hanche
- D. Médicaments antipsychotiques
- E. Immobilisation complète en plâtre

QCM 119: Quels sont les facteurs de risque connus de l'épiphyse fémorale proximale ?

- A. L'obésité
- B. L'hypothyroïdie
- C. L'hyperthyroïdie
- D. L'hypogonadisme
- E. Les synovites transitoires répétées

QCM 120: Quels sont les types de classification utilisés pour l'épiphyse fémorale proximale ?

- A. Aigu
- B. Chronique
- C. Fonctionnel
- D. Stabilité
- E. Hormonal

***QCM 121: Quel est le principal objectif du traitement chirurgical de l'épiphyse fémorale proximale ?**

- A. Réduction et stabilisation du déplacement
- B. Augmentation de la croissance du fémur
- C. Réduction de la douleur uniquement
- D. Amélioration de la mobilité sans stabilisation
- E. Prévention de la nécrose aseptique

QCM 122: Quels facteurs contribuent à l'apparition de la maladie d'Osgood-Schlatter ?

- A. Nécrose avasculaire
- B. Traction du tendon rotulien sur l'apophyse tibiale immature
- C. Hyperlaxité articulaire
- D. Stress répétitif sur la plaque de croissance
- E. Problèmes hormonaux liés à la puberté

QCM 123: Quels traitements sont recommandés pour la maladie d'Osgood-Schlatter ?

- A. Application locale de glace
- B. Physiothérapie et massages avec des pommades anti-inflammatoires
- C. Médicaments anti-inflammatoires oraux à long terme
- D. Repos sportif pendant les périodes douloureuses
- E. Traitement chirurgical immédiat

***QCM 124: Quel est le principal signe clinique de la maladie d'Osgood-Schlatter ?**

- A. Sensibilité et gonflement à la palpation de la tubérosité tibiale
- B. Douleur au genou sans activité sportive préalable
- C. Inflammation de l'articulation du genou
- D. Douleur uniquement après une activité intense
- E. Sensibilité au niveau de l'articulation de la hanche

QCM 125: Quels facteurs peuvent être impliqués dans la survenue de la scoliose ?

- A. Facteurs génétiques
- B. Anomalies de la croissance du rachis
- C. Manque de vitamine D
- D. Anomalies plaquettaires
- E. L'exercice physique excessif

QCM 126: Quelles sont les principales classifications de la scoliose ?

- A. Scoliose idiopathique
- B. Scoliose fonctionnelle
- C. Scoliose congénitale
- D. Scoliose post-traumatique
- E. Scoliose post-infectieuse

***QCM 127: Quel traitement est recommandé pour une scoliose avec une courbure supérieure à 50° ?**

- A. Traitement physiothérapeutique
- B. Port d'un corset orthopédique
- C. Intervention chirurgicale
- D. Traitement médicamenteux
- E. Surveillance sans traitement

QCM 128: Chez quels groupes de personnes les pieds plats ne sont pas considérés comme pathologiques ?

- A. Les enfants de moins de 8 ans
- B. Les enfants de moins de 6 ans
- C. Les adolescents
- D. Les adultes
- E. Les jeunes enfants

QCM 129: Quels sont les types de pieds plats valgus ?

- A. Pied plat rigide valgus
- B. Pied plat valgus flexible
- C. Pied plat valgus avec raccourcissement du tendon d'Achille
- D. Pied plat fonctionnel
- E. Pied plat transitoire

***QCM 130: Quel traitement est recommandé pour un pied plat rigide avec douleur intense ?**

- A. Aucun traitement n'est nécessaire
- B. Utilisation de bottes orthopédiques et physiothérapie
- C. Interventions chirurgicales immédiates
- D. Correction automatique avec l'âge
- E. Port de semelles simples

QCM 131: Quels sont les facteurs de risque potentiels pour le pied bot varus équin congénital ?

- A. Tabagisme maternel
- B. Alcoolisme maternel
- C. Diabète maternel
- D. Infection virale durant la grossesse
- E. Facteurs génétiques

QCM 132: Quelles sont les phases évolutives du pied bot congénital non traité ?

- A. Phase de réductibilité complète
- B. Phase de rigidité absolue
- C. Phase de réductibilité partielle
- D. Phase de rigidité relative
- E. Phase d'aggravation immédiate

***QCM 133: Quelle est la méthode la plus efficace pour traiter le pied bot varus équin congénital ?**

- A. Traitement chirurgical immédiat
- B. Méthode Ponseti
- C. Physiothérapie uniquement
- D. Port de semelles orthopédiques
- E. Utilisation de corsets rigides

QCM 134: Quels sont les facteurs de risque associés au talus valgus congénital ?

- A. Oligoamnios
- B. Poids de naissance élevé
- C. Présentation par le siège
- D. Diabète maternel
- E. Présentation céphalique

QCM 135: Quels traitements sont recommandés pour les formes sévères de talus valgus ?

- A. Physiothérapie et massages
- B. Immobilisation plâtrée en position de correction
- C. Chirurgie immédiate
- D. Orthèses rigides
- E. Aucune intervention nécessaire

***QCM 136: Quel est le pronostic du talus valgus congénital dans la majorité des cas ?**

- A. Le pied ne se corrige jamais
- B. La déformation devient plus sévère avec l'âge
- C. La position vicieuse se corrige spontanément ou par physiothérapie
- D. Une intervention chirurgicale est nécessaire dans tous les cas
- E. Le talus valgus se transforme en pied plat rigide

QCM 137: Quels sont les facteurs de risque du syndrome des loges ?

- A. Fractures
- B. Compression externe par un plâtre serré
- C. Pratique d'exercices physiques modérés
- D. Piqûres d'animaux
- E. Amputations

QCM 138: Quels signes cliniques sont associés au syndrome des loges ?

- A. Douleur intense non soulagée par les analgésiques
- B. Peau rouge et chaude
- C. Pouls faible ou absent
- D. Paralysie de la zone affectée
- E. Augmentation de la pression intra-compartmentale supérieure à 30 mmHg

***QCM 139: Quel traitement est recommandé pour le syndrome des loges ?**

- A. Simple observation sans traitement
- B. Retrait du plâtre ou bandages compressifs
- C. Médicaments antidouleurs uniquement
- D. Chirurgie immédiate sans retrait du plâtre
- E. Immobilisation stricte sans intervention chirurgicale

QCM 140: Quelle est la principale cause de l'ostéomyélite hématogène aiguë chez les enfants de plus de 1 an ?

- A. Streptococcus pneumoniae
- B. Staphylococcus aureus
- C. Mycobacterium tuberculosis
- D. Haemophilus influenzae
- E. Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)

QCM 141: Quels sont les examens diagnostiques utiles dans le diagnostic de l'ostéomyélite hématogène aiguë ?

- A. Radiographie simple
- B. Echographie
- C. Imagerie par résonance magnétique (IRM)
- D. TDM (tomodensitométrie)
- E. Numération formule sanguine (NFS)

***QCM 142: Quel est l'agent infectieux le plus fréquemment incriminé dans l'ostéomyélite aiguë chez les enfants de plus de 1 an ?**

- A. Escherichia coli
- B. Streptococcus pyogenes
- C. Staphylococcus aureus
- D. Salmonella enterica
- E. Pseudomonas aeruginosa

QCM 143: Quelles articulations sont les plus fréquemment touchées par l'arthrite septique chez les enfants ?

- A. Poignet
- B. Coude
- C. Hanche
- D. Genou
- E. Epaule

QCM 144 : Quels sont les agents infectieux les plus fréquemment impliqués dans l'arthrite septique chez les enfants ?

- A. Staphylococcus aureus
- B. Kingella kingae
- C. Streptococcus pneumoniae
- D. Haemophilus influenzae
- E. Mycobacterium tuberculosis

***QCM 145: Quel est le traitement initial recommandé pour l'arthrite septique chez les enfants en attendant les résultats de l'antibiogramme ?**

- A. Antibiotiques par voie orale
- B. Antibiotiques intraveineux à large spectre
- C. Chirurgie seule
- D. Réhydratation intraveineuse
- E. Antifongiques

QCM 146: Quels sont les facteurs qui peuvent provoquer la sténose de la jonction pyélo-urétérale ?

- A. Malformation génétique
- B. Retard dans le processus de recanalisation de l'uretère
- C. Présence d'un vaisseau artériel traversant l'uretère
- D. Infection urinaire
- E. Présence d'une tumeur rénale

QCM 147: Quelles sont les méthodes d'imagerie utilisées pour diagnostiquer et évaluer la sténose de la jonction pyélo-urétérale ?

- A. Echographie
- B. Scintigraphie rénale au Tc-99m DMSA
- C. Radiographie pulmonaire
- D. Uro-CT (Tomodensitométrie) avec contraste
- E. IRM (Imagerie par résonance magnétique)

***QCM 148: Quel est le traitement standard de la sténose de la jonction pyélo-urétérale ?**

- A. Traitement antibiotique
- B. Suivi clinique et échographique uniquement
- C. Pyéloplastie d'Anderson-Hynes
- D. Transplantation rénale
- E. Médicaments anti-inflammatoires

QCM 149: Quels sont les types de mégaurètre mentionnés dans le texte ?

- A. Mégaurètre obstructif
- B. Mégaurètre refluxant
- C. Mégaurètre fonctionnel
- D. Mégaurètre non obstructif, non refluxant
- E. Mégaurètre rénal

QCM 150: Quelles méthodes d'imagerie sont utilisées pour diagnostiquer le mégaurètre et ses complications ?

- A. Echographie
- B. Cystographie
- C. Radiographie pulmonaire
- D. Scintigraphie rénale
- E. IRM abdominale

***QCM 151: Quel est le traitement chirurgical standard pour un mégaurètre obstructif avec une sténose de la jonction urétéro-vésicale ?**

- A. Dilatation endoscopique avec stent urétéral
- B. Pyéloplastie d'Anderson-Hynes
- C. Résection de la portion sténotique et réimplantation de l'uretère dans la vessie
- D. Néphrectomie
- E. Cystoscopie avec drainage

QCM 152: Quelles sont les anomalies qui peuvent résulter d'un système double collecteur ?

- A. Reflux vésico-urétéral
- B. Urétérocèle
- C. Hypoplasie rénale
- D. Sténose urétéro-vésicale
- E. Hydronéphrose

QCM 153: Quelles techniques d'imagerie sont utilisées pour évaluer le système double collecteur ?

- A. Echographie postnatale
- B. Cystographie
- C. Radiographie abdominale
- D. Scintigraphie rénale au DMSA
- E. Uro-IRM

***QCM 154: Quel est le traitement recommandé pour un patient asymptomatique présentant un système double collecteur ?**

- A. Antibiothérapie prolongée
- B. Traitement chirurgical immédiat
- C. Surveillance sans traitement
- D. Réimplémentation de l'uretère
- E. Néphrectomie partielle

QCM 155: Quelles sont les causes fréquentes de l'urétérocèle ?

- A. Résorption incomplète de la membrane urétérale de Chwalla
- B. Sténose urétéro-vésicale
- C. Infection urinaire fréquente
- D. Anomalie de la jonction pyélo-urétérale
- E. Présence d'une duplication urétérale

QCM 156: Quels examens permettent de diagnostiquer l'urétérocèle ?

- A. Echographie postnatale
- B. Echographie fœtale
- C. Cystographie
- D. Radiographie abdominale
- E. Uro-IRM ou uro-TDM

***QCM 157: Quel est le traitement de première intention pour une urétérocèle ?**

- A. Traitement médical par antibiotiques
- B. Chirurgie ouverte pour réimplanter l'uretère
- C. Traitement endourologique par cystoscopie
- D. Dialyse
- E. Néphrectomie partielle

QCM 158: Quelles sont les caractéristiques anatomiques de l'extrophie vésicale ?

- A. Absence de la paroi abdominale antérieure
- B. La vessie est séparée du bas-ventre
- C. Présence d'une déformation du clitoris chez les filles
- D. La vessie est continue avec l'urètre, sans paroi antérieure
- E. Les corps caverneux du pénis sont divergents chez les garçons

QCM 159: Quel diagnostic et traitement sont associés à l'extrophie vésicale ?

- A. Le diagnostic peut être posé par échographie à partir de la 18e à 20e semaine de grossesse
- B. Un traitement médical est généralement suffisant pour fermer la vessie
- C. Le traitement de première intention est chirurgical et doit être réalisé dans les 72 heures suivant la naissance
- D. Chez les garçons, l'épispadias est corrigé à 6-12 mois
- E. Une IRM fœtale est rarement utilisée pour diagnostiquer cette malformation

***QCM 160 : Quel est le pronostic de l'extrophie vésicale ?**

- A. Le pronostic est généralement bon, sans complications après le traitement
- B. Le pronostic dépend de la gravité de la malformation et de la précocité du traitement
- C. Le pronostic ne varie pas selon l'âge de la personne
- D. Le pronostic est uniquement fonction de la capacité rénale
- E. Les patients n'ont généralement pas de problèmes d'incontinence

QCM 161: Quels sont les types de valves urétrales postérieures selon la classification de

Young ?

- A. Type I : Replis urétraux partant sous le verumontanum et fusionnant en avant
- B. Type II : Replis fortement proéminents allant du verumontanum au col vésical
- C. Type III : Diaphragme perforé au-dessus ou au-dessous du verumontanum
- D. Type IV : Replis urétraux au niveau de la vessie uniquement
- E. Type V : Anomalies anatomiques observées au niveau de la vessie

QCM 162: Quels sont les signes cliniques pouvant indiquer des valves urétrales postérieures chez un nourrisson ?

- A. Oligo-anurie, vessie globulaire et abdomen en trèfle
- B. Dysurie, jet urinaire faible, et lombalgie chez les plus âgés
- C. Fièvre et insuffisance rénale chronique
- D. Vessie pleine à paroi épaisse et urétérohydronéphrose bilatérale
- E. Symptômes digestifs sévères comme des vomissements persistants

***QCM 163: Quel est le traitement de choix pour les valves urétrales postérieures après la naissance ?**

- A. Chirurgie de réimplantation urétérale
- B. Ablation endoscopique des valves
- C. Traitement médical avec antibiotiques à vie
- D. Drainage par néphrostomie percutanée
- E. Radiothérapie ciblée sur les valves

QCM 164: Quelles sont les principales anomalies anatomiques observées chez un patient atteint d'hypospadias ?

- A. Méat urétral ectopique sur la face antérieure du pénis
- B. Présence d'un prépuce circulaire complet
- C. Corde fibreuse proximale entraînant une courbure du pénis
- D. Prépuce incomplet avec un excès cutané sur la face dorsale du pénis
- E. Méat urétral situé sur la face dorsale du pénis

QCM 165: Quels sont les objectifs principaux du traitement chirurgical de l'hypospadias ?

- A. Obtenir une courbure du pénis plus prononcée
- B. Amener le méat urétral jusqu'à l'extrémité du pénis
- C. Formation d'un gland symétrique et conique
- D. Créer une sténose urétrale de calibre suffisant
- E. Obtenir une apparence cosmétique optimale, y compris le prépuce

***QCM 166: Qu'est-ce qui distingue l'épispadias de l'hypospadias ?**

- A. L'épispadias présente un méat urétral situé sur la face dorsale du pénis
- B. L'épispadias est une malformation seulement chez les garçons
- C. L'épispadias est une malformation du scrotum
- D. L'épispadias est uniquement diagnostiqué prénatalement
- E. L'épispadias est une malformation fréquente comparée à l'hypospadias

QCM 167: Quelles sont les causes possibles du phimosis acquis ?

- A. Traumatisme local (décapitations intempestives)
- B. Infection urinaire
- C. Balanite aiguë ou chronique
- D. Phimosis congénital
- E. Infection de la peau autour du prépuce

QCM 168: Quelles sont les principales conséquences du phimosis chez les adolescents et les adultes

- A. Infections urinaires
- B. Dysfonctionnement sexuel
- C. Douleur au niveau du pénis, surtout en érection
- D. Difficultés à uriner
- E. Amélioration de la circulation sanguine

***QCM 169: Quel est le traitement recommandé pour un phimosis cicatriciel lorsque les manœuvres de décapitation n'ont pas fonctionné ?**

- A. Traitement antibiotique
- B. Péritonite dorsale de Duhamel
- C. Circoncision
- D. Traitement à base de crèmes
- E. Observation sans traitement